

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL – PATRIE

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA

GROUPE TECHNIQUE CENTRAL



REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE - WORK – FATHERLAND

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

NATIONAL AIDS CONTROL
COMMITTEE

CENTRAL TECHNICAL GROUP

RAPPORT 2015

ESTIMATIONS ET PROJECTIONS SUR LE VIH ET LE SIDA AU CAMEROUN

PERIODE : 2010-2020



JUILLET 2015

Table des matières

ABREVIATIONS/ACRONYMES	v
LISTE DES TABLEAUX	vii
LISTE DES FIGURES.....	viii
REMERCIEMENTS	ix
INTRODUCTION	10
I-METHODOLOGIE D'ESTIMATION DES TENDANCES DE L'EPIDEMIE A VIH ET DU SIDA	12
I.1 LOGICIELS DE PROJECTION UTILISÉS	12
I.2 TYPES DE DONNEES UTILISEES POUR LES PROJECTIONS ET ESTIMATIONS	14
I.2.1 Les données démographiques.....	14
I.2.2 Les données du programme.....	14
I.2.3 Eligibilité au traitement	15
I.2.4 Données d'incidence	15
I.2.5 Composition sexe/âge de la population.....	16
I.2.6 Les indicateurs pour les options avancées	16
II. Profil épidémiologique et démographique	17
II.1. Profil démographique du Cameroun.....	17
II.2. Situation épidémiologique du VIH/SIDA	17
II.2.1 Au sein de la population générale.....	17
II.2.2 Chez les femmes enceintes	18
II.2.3 Au sein des groupes à haut risque	19
III. RESULTATS DES ESTIMATIONS ET PROJECTIONS DU VIH ET DU SIDA AU CAMEROUN DE 2010 A 2020..	20
III.1. Projections et estimations dans la population générale de 2010 à 2020	20
III.1.1. Population totale de PV VIH	20
III.1.2. Nouvelles infections à VIH par tranche d'âge	21
III.1.3. Prévalence du VIH dans la population de 15-49 ans.....	22
III.1.4. Besoins en TARV par tranche d'âge.....	23
III.1.5. Décès liés au VIH/SIDA	24
III. 2 Projections et estimations dans la population des 15 ans et plus de 2010 à 2020.....	24
III.2.1. Nombre de PVVIH dans la tranche d'âge de 15-24 ans.....	24
III.2.2. Nombre de décès liés au VIH/SIDA (15-24 ans)	25
III.2.3. Femmes enceintes séropositives âgées de 15 à 24 ans	26

III. 3 Projections et estimations chez les nourrissons de 2010 à 2020.....	26
III.3.1. Nombre de nourrissons atteints du VIH/SIDA.....	26
III.3.2. Nouvelles infections à VIH/SIDA chez les nourrissons	27
III.3.3. Décès des nourrissons liés au VIH/SIDA.....	27
III. 4. Projections et estimations pour la PTME de 2010 à 2020.....	28
III.4.1. Option A et B+	28
III.4.2. Nombre de femmes séropositives allaitant à 3 et 12 mois.....	28
III.4.3. Couverture PTME, Taux de transmission mère-enfant à 6 semaines, taux de transmission final incluant la période d'allaitement	29
III.4.4. Nombre de nouvelles infections chez les enfants dues à la transmission de la mère à l'enfant....	29
III. 4.5. Femmes enceintes séropositives présentant un nombre de CD4< 350, nombre d'enfants séropositifs	30
III.4.6. Population totale des enfants âgés de 1 à 4 ans.....	31
III.4.8. Nouvelles infections chez les PVVIH âgées de 1 à 4 ans	32
III.4.9.Décès dus au VIH dans la population de 1 à 4 ans	32
III.4.10.Enfants VIH+ âgés de moins de 2 ans.....	33
III.5. Récapitulatifs des impacts.....	34
III.6. Orphelins du SIDA.....	34
IV - CONCLUSION.....	35
BIBLIOGRAPHIE.....	36
ANNEXE : Liste des personnes ayant contribué à la production de ce rapport	37
ANALYSE DES INCERTITUDES.....	39
1. Nombre total des nouvelles infections	39
2. Total adultes et enfants VIH+	39
3. Total annuel des décès liés au SIDA	40
4. Nouvelles infections au VIH des PVVIH âgées de 15 ans et plus.....	40
5. Décès annuel du au VIH chez les 15 ans et plus.....	41
6. Population de VIH des enfants	42
7. Nouvelles infections à VIH chez les enfants	42
8. Décès annuel liés au SIDA chez les enfants.....	43
9. Besoin de thérapie ARV chez les enfants	43
10. Décès annuels dus au SIDA chez les enfants de 1-4 ans	44

11.	Nouvelles infections à VIH chez les Hommes de 15 à 24 ans.....	45
12.	Nouvelles infections à VIH chez les Femmes de 15 à 24 ans	45
13.	Décès annuels liés au SIDA chez les adultes de 15 à 24 ans	46
14.	Mères ayant besoin de PTME.....	47
15.	Orphelins du SIDA.....	47
16.	Tableau récapitulatif, estimations de l'année 2015.....	48
	Tableau récapitulatif	51

ABREVIATIONS/ACRONYMES

ARV	Antirétroviraux
BUCREP	Bureau Camerounais de Recensement de la Population
CNLS	Comité National de Lutte contre le SIDA
DLMEP	Direction de la Lutte contre la Maladie des Epidémies et Pandémies
EDS III	Enquête Démographique et de Santé
EPP	Estimations and Projections Packages
GTC	Groupe Technique Central
INS	Institut National de la Statistique
MIN SANTE	Ministère de la Santé Publique
NVP	Névirapine
M I O	Médicaments contre Infections Opportunistes
OEV	Orphelin et Enfant Vulnérable
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
ONU SIDA/ UNAIDS	Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA
PEC	Prise En Charge
PNLS	Programme National de Lutte contre le sida
PTME	Prévention de la Transmission de la Mère à l'Enfant
PVVIH	Personne Vivant avec le VIH
RGPH	Recensement général de la population et de l'habitat
SIDA	Syndrome d'Immuno Déficience Acquise
SPSE	Section Planification Suivi et Evaluation
TAR	Traitement Antiretroviral

TME	Transmission de la Mère à l'Enfant
TB	Tuberculose
UNFPA	United Nations Funds for Population
UNPOP	Division de la Population des Nations Unies
VIH	Virus de l'Immunodéficience Humaine

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Evolution de la population du Cameroun 2010-2020.....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 2: Répartition du nombre de PVVIH par tranche d'âge.....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 3: Répartition des nouvelles infections par tranches d'âge de 2010 à 2020	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 4: Prévalence du VIH par sexe, de 2010 à 2020 chez les 15 à 49 ans.	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 5: Besoin en ARV par tranche d'âge	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 6 : Nombre de nouveaux enfants infectés dus à la transmission mère-enfant.	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 7:Récapitulatifs des impacts observés	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 8: Orphelins du SIDA	Erreur ! Signet non défini.

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Structure d'EPP-SPECTRUM	Erreur ! Signet non défini.
Figure 2: Prévalence du VIH au Cameroun	Erreur ! Signet non défini.
Figure 3: Répartition du nombre de PVVIH par sexe de 2010 à 2020.....	Erreur ! Signet non défini.
Figure 4: Répartition par sexe du nombre de décès liés au VIH/SIDA de 2010 à 2020.	Erreur ! Signet non défini.
Figure 5: Répartition du nombre de PVVIH âgés entre 15-24 ans	Erreur ! Signet non défini.
Figure 6: Décès annuels liés au VIH/SIDA chez les 15 à 24 ans	Erreur ! Signet non défini.
Figure 7: Evolution du nombre de femmes enceintes séropositives âgées entre 15 à 24 ans.....	Erreur ! Signet non défini.
Figure 8: Evolution, selon le sexe, du nombre de nourrissons atteints du VIH/SIDA entre 2010 et 2020	Erreur ! Signet non défini.
Figure 9: Evolution des nouveaux nourrissons infectés par le VIH/SIDA entre 2010 et 2020 par sexe	27
Figure 10: Courbe de l'évolution des décès liés au VIH/SIDA, par sexe, chez les nourrissons entre 2010 et 2020	Erreur ! Signet non défini.
Figure 11: Tendance des besoins en ARV pour la PTME de 2010 à 2020	Erreur ! Signet non défini.
Figure 12: Nombre de femmes séropositives allaitant à 3 et 12 mois	Erreur ! Signet non défini.
Figure 13: Couverture, Taux de TME à 6 semaines, taux de transmission final incluant la période d'allaitement	Erreur ! Signet non défini.
Figure 14 : Femmes enceintes séropositives présentant un nombre de CD4<350 et Nombre d'enfants séropositifs	Erreur ! Signet non défini.
Figure 15: Couverture des traitements pour les femmes enceintes séropositives	Erreur ! Signet non défini.
Figure 16: Population totale des enfants âgés de 1 à 4 ans.....	Erreur ! Signet non défini.
Figure 17: Nouvelles infections dans la tranche d'âge de 1 à 4 ans.....	Erreur ! Signet non défini.
Figure 18: Décès chez les PVVIH de 1 à 4 ans	Erreur ! Signet non défini.
Figure 19: Population de PVVIH chez enfants de moins de 2 ans	Erreur ! Signet non défini.

REMERCIEMENTS

Le présent document est la sixième édition du profil de projections et d'estimations de l'épidémie à VIH et sida au Cameroun réalisée par le MIN SANTÉ et le Groupe Technique Central du Comité National de lutte Contre le Sida.

Le rapport 2015 des estimations et de projections du VIH pour la période 2010-2020 au Cameroun est le résultat des efforts concertés du Gouvernement et des partenaires au développement.

Le présent rapport a été élaboré grâce à la synergie des efforts et à l'esprit de franche collaboration des personnes ressources, des agences et des institutions partenaires. À cet effet, nous saisissons cette opportunité pour adresser notre reconnaissance et notre profonde gratitude :

- A l'ONU SIDA et à l'UNICEF pour l'assistance technique et financière apportée à la réalisation de ce travail ;
- A tous les acteurs, tant nationaux qu'internationaux, qui y ont contribué, par leurs réflexions, conseils, observations et suggestions ;
- Aux membres du Groupe Technique Suivi-Evaluation qui ont analysé, commenté et validé les présentes projections.

Ces résultats n'auraient pu être atteints sans l'engagement et la contribution de qualité de l'ensemble des acteurs de la lutte à qui nous renouvelons nos sincères remerciements et un encouragement à la poursuite et la prise en main des éditions futures.

Enfin, nos sincères remerciements et notre gratitude vont à l'endroit de tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail mais surtout aux partenaires toujours prêts à soutenir le processus d'élaboration de cet important document de planification et de plaidoyer.

Dr ELAT NFETAM Jean Bosco

Secrétaire Permanent du GTC/CNLS

INTRODUCTION

L'infection à VIH a fait son apparition autour des années 1980 et les premiers cas ont été décelés au Cameroun en 1985. Elle atteint les proportions d'une épidémie généralisée dans les années 90. Les dispositifs de riposte ont été immédiatement mis sur pied, d'une part pour réduire le nombre de nouvelles infections dans la population sexuellement active et chez les enfants et d'autre part, assurer l'accès au traitement pour les personnes vivant avec le virus et réduire son impact sur les Orphelins et Enfants Vulnérables (OVE).

Selon les résultats de l'Enquête Démographique et de Santé (EDS-MIS 2011), la prévalence du VIH dans la population générale de 15-49 ans est de 4,3% contre 5,5% en 2004. Cette prévalence est nettement plus élevée chez les femmes que les hommes (5,6% contre 2,9%). La tranche de 35 à 39 ans est la plus touchée avec une prévalence de 8,1% en 2011. La prévalence du VIH est également très élevée chez les veuves (17,9%), les divorcées/séparées (15,7%) et les veufs (10,6%). Dans les groupes les plus exposés au risque et les plus vulnérables, les prévalences sont plus élevées que dans la population générale ; 44,3% à Yaoundé et 24,2% à Douala en 2011 chez les hommes ayant des rapports avec les hommes, 36,8 % en 2009. chez les travailleuses de sexe (TS), 16,2% en 2005. chez les camionneurs et 6% en 2011 chez les hommes en tenue.

Compte tenu de ce qui précède des politiques de riposte, des stratégies de lutte concrètes et fiables, doivent être définies et régulièrement révisées, adaptées. Ceci nécessite de disposer d'informations sur la situation épidémiologique du Cameroun et des besoins en traitement pour des personnes infectées. A cet effet, depuis 1997, l'ONU SIDA et l'OMS publient périodiquement des estimations par pays de la situation de l'infection à VIH. Le Cameroun se doit de contribuer à cette surveillance globale.

Le présent document, élaboré par le GTC-CNLS du Cameroun avec l'appui technique de l'ONU SIDA a pour but de contribuer à l'amélioration de l'efficacité de la réponse du Cameroun face à l'épidémie de VIH et Sida. Ce document s'appuie sur les données d'enquêtes de population et de surveillance sentinelle, des résultats des recherches dans le domaine du VIH et les données des rapports de suivi du programme. Il s'articule sur les résultats relatifs au profil évolutif du VIH et Sida, aux besoins en traitement antirétroviral et Médicaments pour Infections Opportunistes (M I O) et enfin à la mortalité liée au Sida. Il tient compte des décisions stratégiques majeures prises par le pays à savoir la mise sous traitement des PV VIH adultes avec un seuil de CD4 égal à 500 ainsi que la stratégie

« test and treat » pour certains groupes de la population (femmes enceintes, enfants de moins de 5 ans, les professionnelles de sexe, les hommes ayant des rapports avec les hommes, les patients Co-infectés TB/VIH et VIH/Hépatite B).

Il se veut un document de référence pour l'ensemble des intervenants dans le domaine et un outil de plaidoyer auprès des décideurs et autres acteurs. En outre, il ambitionne d'aider à améliorer la planification, la priorisation et l'harmonisation des interventions et contribuer au suivi et à l'évaluation de la réponse nationale contre le VIH et le Sida.

I-METHODOLOGIE D'ESTIMATION DES TENDANCES DE L'EPIDEMIE A VIH ET DU SIDA

Du fait que les principaux indicateurs du VIH sur le plan national et mondial requièrent une modélisation des données, les dix dernières années ont été marquées par la recherche de logiciels appropriés pouvant rendre fidèlement compte de la situation épidémiologique en matière de VIH et du Sida à un moment donné et de faire des projections fiables à un horizon donné. Les estimations et projections contenues dans ce document sont effectuées à l'aide de deux logiciels combinés « Estimations et Projections par Pays (EPP) » et « SPECTRUM » version 2015 conformément aux orientations de l'ONUSIDA.

En effet, les estimations et projections s'effectuaient à l'aide d'un certain nombre de logiciels, parmi lesquels le logiciel EPP qui permettait d'établir une courbe de l'épidémie du VIH sur la base de données de la séro-surveillance sentinelle. Aujourd'hui renforcée par un autre logiciel, SPECTRUM, la courbe épidémique générée par EPP comme donnée d'entrée permet de produire des estimations relatives à la prévalence, au nombre de séropositifs, aux besoins en traitement antirétroviral (ARV) et PTME, au nombre de nouvelles infections, à la mortalité liée au Sida et au nombre d'orphelins.

Les progrès réalisés pour le perfectionnement de ces outils d'estimation et de projection ont permis à l'ONUSIDA et à l'OMS de mettre au point un logiciel qui fusionne les fonctions de deux logiciels précédemment utilisés afin de faciliter la manipulation de cet outil par les pays. Ce logiciel est mis à jour régulièrement.

Les projections réalisées en Juin 2015 utilisent un seul logiciel appelé EPP-SPECTRUM qui permet d'avoir un profil évolutif Pays en matière de VIH Sida sur la base de données d'enquêtes de population et de surveillance sentinelle, des résultats des recherches dans le domaine du VIH, des décisions stratégiques du pays et des données des rapports de suivi du programme et des hypothèses de progression.

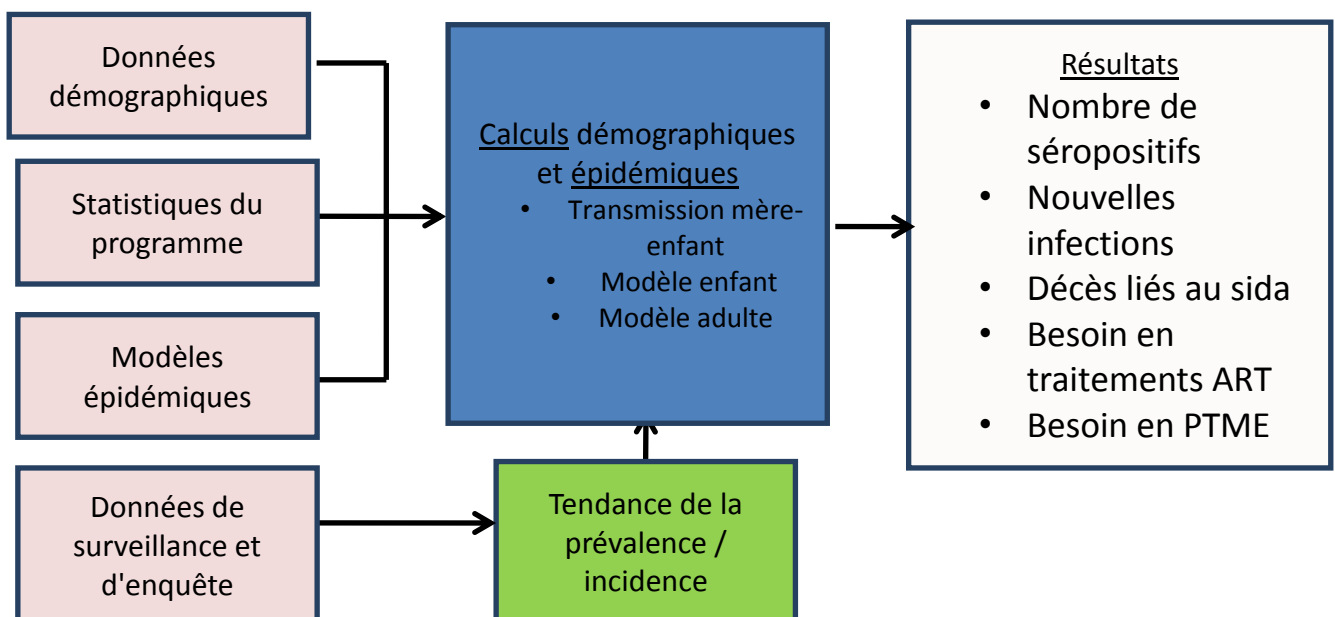
I.1 LOGICIELS DE PROJECTION UTILISÉS

Le logiciel EPP, permet de modéliser les épidémies nationales en incluant les différentes sous populations (urbain/rural, région, groupes à risques). Sur la base de plusieurs données consensuelles validées par le pays (taux de croissance de la population, taux de natalité, taux de mortalité, données de surveillance

sentinelle du VIH chez les femmes enceintes, etc.) EPP génère, par un algorithme amélioré, les meilleurs ajustements et prévalences à court terme (moins de 5 ans) qui servent de matériel pour le logiciel « SPECTRUM » dans la détermination de l'incidence, des impacts, des besoins en ARV et autres intrants. Le logiciel EPP utilise les tendances observées de la prévalence pour calculer l'évolution de l'incidence au fil du temps uniquement pour le groupe des 15 - 49 ans y compris les enfants. Les informations saisies sont les données de surveillance et les données issues de Spectrum pour obtenir l'incidence au sein de la population des 15 - 49 ans.

Le logiciel *SPECTRUM* se sert de la projection de l'incidence produite par *EPP* pour calculer les statistiques liées à la population, ainsi que les estimations des besoins dans le cadre des programmes de prévention (PTME, prévention des infections opportunistes) et de traitement (ARV pour adultes et enfants) etc.

Le schéma de projection se fait selon la figure ci-après



I.2 TYPES DE DONNEES UTILISEES POUR LES PROJECTIONS ET ESTIMATIONS

I.2.1 Les données démographiques

Ces données sont fournies par défaut par le logiciel *EPP* et proviennent de la Division de la Population des Nations Unies, pour chaque pays (UNPOP) qui procède à des mises à jour régulières. Ce sont essentiellement les données sur la distribution de la population, (les taux de natalité, morbidité, de mortalité, de croissance de la population, de l'espérance de vie, et les migrations internationales).

I.2.2 Les données du programme

En ce qui concerne la PTME et le traitement par les ARV pour adultes et enfants, les données programmatiques datant du début de l'approvisionnement des antirétroviraux au Cameroun sont introduites dans le logiciel SPECTRUM.

Pour les données sur la PTME, sont requis:

- La répartition des femmes enceintes VIH+ par type de protocole reçu pour la prophylaxie prénatale (aucune, Névirapine mono dose, bi prophylaxie ARV, option A et option B, Traitement antirétroviral entamé avant la grossesse en cours, Traitement ART entamé pendant la grossesse en cours, > 4 semaines avant l'accouchement et Traitement ART entamé pendant la grossesse en cours, < 4 semaines avant l'accouchement) ;
- La prophylaxie postnatale (Nombre de prophylaxies postnatales commencées pour les Options A et B, Taux mensuel d'abandon pendant l'allaitement pour les Opt. A, B, ART, Durée de l'allaitement (données de DHS par défaut)) ;

Pour les données de traitements ARV concernant les adultes et les enfants, sont requis:

- Le nombre ou pourcentage d'adultes éligibles aux traitements ART par sexe et par année ;
- La numération médiane des CD4 en début de traitement ;
- Le pourcentage de personnes perdues de vue chaque année ;
- *En Alternatives* : le nombre de traitements ART récemment entamés chaque année, le nombre ou pourcentage par taux de CD4 ;

- Le nombre d'enfants recevant du cotrimoxazole par an ;
- Le nombre d'enfants sous ART par an ;
- Le pourcentage recevant un diagnostic infantile précoce.

1.2.3 Eligibilité au traitement

Les conditions d'éligibilité introduites dans le logiciel SPECTRUM concernent essentiellement les critères retenus par le pays d'après les recommandations de l'OMS.

- Pour les patients adultes, les données considérées sont respectivement, CD4 inférieur ou égal à 200 (avant 2010), CD4 inférieur ou égal à 350 (de 2010 à 2013), CD4 inférieur ou égal à 500 à partir de 2014
- Pour les enfants infectés par le VIH, il s'agit en plus des valeurs par défaut (seuils de CD4) générées par le logiciel en fonction de l'âge, de l'âge inférieur à 60 mois (à partir de 2014).
- Les femmes enceintes VIH+, les patients co-infectés TB/VIH, les couples sérodiscordants, les travailleurs de l'industrie du sexe et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

1.2.4 Données d'incidence

▪ Les données de surveillance du VIH

Dans un contexte d'épidémie généralisée, les données de prévalence obtenues dans les sites de surveillance sentinelle du VIH chez les femmes enceintes sont considérées comme les meilleurs intrants du logiciel pour estimer la prévalence nationale. Ces sites ont été classés en zones urbaine et rurale. Les données intégrées dans le logiciel SPECTRUM couvrent la période allant de 1987 à 2012, dernière année où s'est déroulé l'enquête de séro-surveillance sentinelle au Cameroun.

▪ Surveillance du VIH dans la population générale

Il s'agit essentiellement des données de prévalence du VIH en milieux urbain et rural telles que révélées par les enquêtes dans la population générale (EDS III-2004, EDS-MICS IV-2011).

1.2.5 Composition sexe/âge de la population

Il s'agit du ratio femme-homme chez les 15-49 ans d'une part, (rapport de masculinité) et d'autre part de la distribution par âge des nouveaux cas de VIH.

1.2.6 Les indicateurs pour les options avancées

Il s'agit notamment :

- Du taux annuel de progression vers la prochaine catégorie de CD4 la plus basse par sexe, par tranches d'âge et par niveau de CD4 ;
- De la répartition (pourcentage) de nouvelles infections par sexe, par tranche d'âge et par niveau de CD4 ;
- De la mortalité liée au VIH sans ARV (Probabilité annuelle)
- De la mortalité liée au VIH avec ARV (réduction de la transmission du VIH lorsque tous les patients sont sous ARV et la probabilité annuelle de mortalité liée au VIH sous ARV en fonction du nombre de CD4 au début du traitement) ;
- De l'augmentation annuelle des décomptes des CD4 sous ARV ;
- Des années dans la catégorie de décompte de CD4 (nombre moyen, dans la catégorie de décompte des CD4) ;
- Du délai moyen entre le moment de l'infection jusqu'au décès de suite du sida ;
- De la survie des enfants sous ARV.

II. Profil épidémiologique et démographique

II.1. Profil démographique du Cameroun

La population du Cameroun au 1^{er} janvier 2010 est estimée à 19 406 100 habitants. Selon les tendances issues des résultats définitifs du 3^{ème} RGPH et reprises dans le tableau ci-après, l'effectif de cette population sera de 24 910 305 âmes en 2020, soit une évolution démographique de 79%, avec un taux annuel moyen d'accroissement oscillant autour de 2,5%

	Femmes	Hommes	Total
2 010	9 940 969	7 970 731	17 911 700
2 011	10 189 064	9 949 573	20 138 637
2 012	10 441 184	10 195 770	20 636 954
2 013	10 697 334	10 445 903	21 143 237
2 014	10 957 519	10 699 969	21 657 488
2 015	11 224 693	10 955 014	22 179 707
2 016	11 493 006	11 216 886	22 709 892
2 017	11 765 359	11 482 685	23 248 044
2 018	12 041 739	11 752 425	23 794 164
2 019	12 322 143	12 026 108	24 348 251
2 020	12 609 916	12 300 389	24 910 305

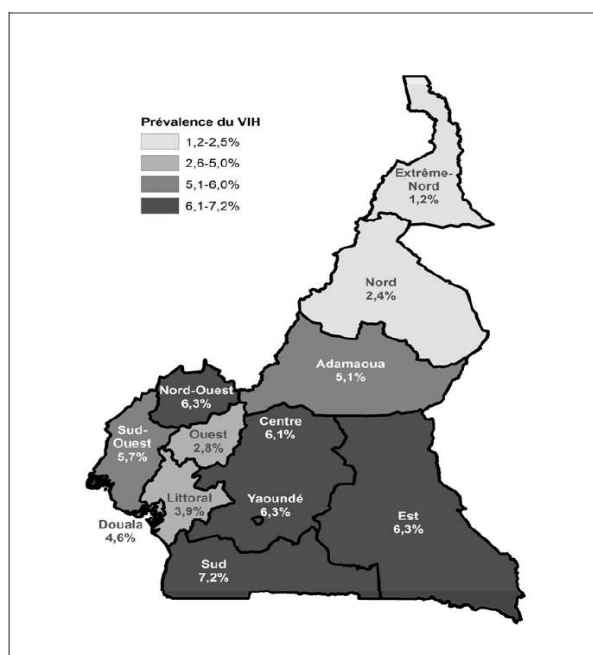
Source : BUCREP 2010

II.2. Situation épidémiologique du VIH/SIDA

II.2.1 Au sein de la population générale

Les résultats de l'EDS-MICS 2011 montrent qu'au Cameroun, 4,3% des adultes âgés de 15 -49 ans sont séropositifs. Toutefois, on note une disparité d'une région à l'autre. (Voir figure 1)

La prévalence chez les femmes de 15-49 ans (5,6%) est près du double de celui estimé chez les hommes de même âge (2,9%) soit 190 femmes infectées pour 100 hommes ce qui signifie que les



femmes sont nettement plus vulnérables à l'infection à VIH que les hommes. Chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans elle est de 1,7% (1,2% de 15 à 19 ans et 2,2 % de 20 à 24 ans).

Les estimations sur l'impact de l'infection à partir du logiciel d'Estimation et Projection Spectrum révèlent qu'en 2015, 666 528 personnes sont infectées dont 58% de femmes. Le nombre de décès annuel liés au VIH est estimé à 34 158 en 2014.

S'agissant de la connaissance du VIH/sida, selon l'EDS-MICS IV, bien que la quasi-totalité des camerounais ait déclaré avoir entendu parler du VIH/Sida, seulement 26% des femmes et 33% des hommes de 15-49 ans en ont une connaissance approfondie. Seulement 48% des femmes et 37% des hommes savent que le VIH peut être transmis en allaitant et que le risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant peut être réduit par la prise des ARV pendant et après la grossesse.

Selon l'EDS-MICS 2011, 46% des femmes et 58% des hommes n'ont jamais effectué le test du VIH. Cependant il faut noter que le nombre moyen de partenaires sexuels sur la durée de vie est estimé à 3,1 chez les femmes contre 12,1 chez les hommes. 43% des hommes ayant des partenaires multiples, ont utilisé un condom au cours des derniers rapports sexuels contre 37% de femmes. Au plan national, seulement 12% des femmes et 18% des hommes se seraient comportés de manière tolérante envers les PVVIH. Parmi les femmes ayant eu plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois, 37 % (contre 43% chez les hommes) ont déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours de leurs derniers rapports sexuels.

II.2.2 Chez les femmes enceintes

Le rapport préliminaire de l'étude de faisabilité d'un système de surveillance sentinelle basée sur les données PTME au Cameroun, couplée à la surveillance sentinelle du VIH chez les femmes enceintes réalisée en 2012 montre une prévalence du VIH de 7,8% contre 7,57% en 2009 dans ce groupe. Ce taux varie de 7,4% en milieu rural à 8,1% en zone urbaine.

Selon l'enquête EDS-MICS 2011, 38,3% des femmes enceintes ont bénéficié du consulting au cours de la CPN et ont effectués le test et reçu le résultat. Les données de routine du dépistage en consultation prénatale

indiquent un taux de séropositivité de 6,5% en 2014 contre 8,4% en 2011. Ce pourcentage cache des disparités interrégionales avec 87,1% dans la région du Nord-ouest contre 10,9% dans la région du Nord.

II.2.3 Au sein des groupes à haut risque

L'estimation de la taille des Professionnel(le)s de sexe (PS) était de 98 102 sur le territoire national, et environ 38 000 dans les grandes villes Douala et Yaoundé en 2013. La prévalence moyenne du VIH observée en 2009 parmi les 999 PS était de 36%, tandis que celle de la syphilis était de 17,5% avec des fortes disparités régionales (de 23,9% au Sud à 49,5% dans l'Adamaoua pour le VIH ; de 4% au Sud-ouest à 32,2% à l'Ouest pour la syphilis).

Les camionneurs constituent l'une des principales clientèles des PS. Selon un consensus national de 2013, les camionneurs de longue distance (CLD) formaient une population estimée à 65 333. Cette population constitue la principale clientèle des PS. Il existe peu de données épidémiologiques récentes sur la situation du VIH chez les camionneurs du Cameroun. Une étude réalisée en 2004 a montré une prévalence du VIH de 16,3% parmi les camionneurs avec des disparités notables selon les axes routiers.

En 2013, selon le rapport final « HIV Prévention for Populations at Risk in Cameroon », l'estimation de la taille de la population des HSH était de 38 582 sur l'ensemble du territoire national. Il existe peu de données épidémiologiques récentes sur la situation du VIH chez les HSH du Cameroun. Pour combler le manque d'informations stratégiques sur le VIH parmi les HSH, les données programmatiques des différents intervenants auprès de cette population ont été triangulées. Dans un échantillon de 205 et 255 HSH à Yaoundé et Douala, le taux de séropositivité au VIH s'est situé entre 44,3% et 24,2% respectivement en 2012 selon une étude intégrée de surveillance comportementale et biologique chez les HSH.

Les valeurs utilisées à ce niveau sont des valeurs par défaut, chaque fois que le pays ne dispose pas de résultats d'enquêtes validées.

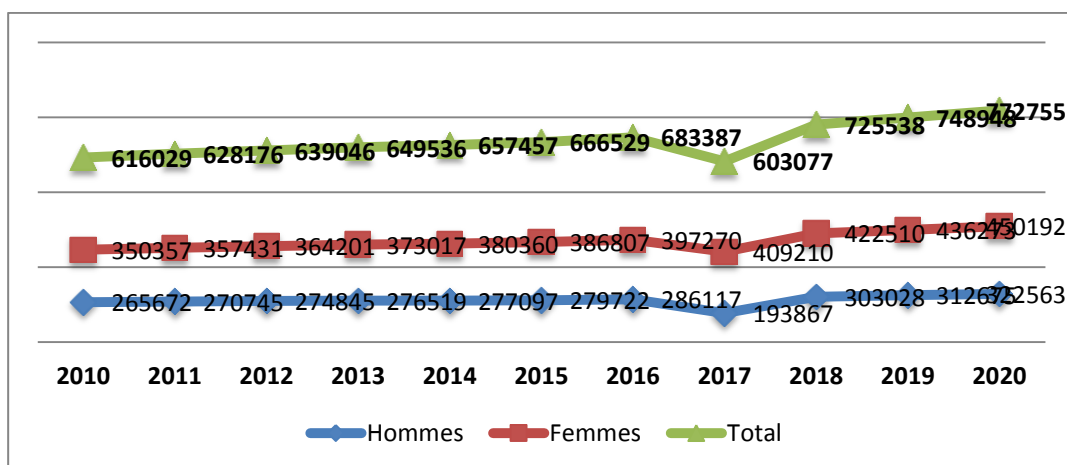
III. RESULTATS DES ESTIMATIONS ET PROJECTIONS DU VIH ET DU SIDA AU CAMEROUN DE 2010 A 2020

Les données d'enquêtes démographiques et de surveillance, les données de programme jusqu'à 2014 et les hypothèses de progression jusqu'en 2020 ont été introduites dans le logiciel SPECTRUM. Sur cette base, SPECTRUM a modélisé l'épidémie nationale en déterminant la courbe d'estimation la plus vraisemblable pouvant décrire à court terme la meilleure tendance de l'épidémie. Cette modélisation a généré les projections présentées et décrites dans les lignes ci-après.

III.1. Projections et estimations dans la population générale de 2010 à 2020

III.1.1. Population totale de PV VIH

Le graphique ci-dessous, présente l'évolution du nombre de PV VIH (nouvelles personnes infectées+PV VIH maintenues en vie) entre 2010 et 2020. Cette série présente une tendance à la hausse, entre 2010 et 2020, aussi bien chez les personnes de sexe masculin (augmentation moyenne de 21,4 % entre 2010 et 2020), que chez les personnes de sexe féminin (augmentation moyenne de 28,5 % entre 2010 et 2020). En effet, l'on observera une hausse du nombre de PV VIH sur toute la période pour atteindre 772 755 PV VIH en 2020. Par ailleurs, suivant les hypothèses précédentes, la population féminine de PV VIH va demeurer plus infectée (58% de la population totale des PV VIH).



Dans le tableau qui suit, il est présenté les mêmes données que dans le tableau ci-dessus, mais détaillées par tranches d'âges. Il ressort qu'entre 2010 et 2020, la

tranche d'âge 55-59 ans qui connaîtra la plus forte hausse (en moyenne 96,07%) ; suivit par le groupe des 50-54 ans. Par ailleurs, la tranche d'âge qui connaîtra une importante baisse entre 2010 et 2020, est celle des 0-4 ans (baisse en moyenne de 52,13%).

Tranche d'âge	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Taux moyen d'évolution entre 2010 et 2020 (en %)
0-4	25 070	24 554	23 728	22 495	21 263	18 831	16 628	14 022	12 475	11 431	12 002	-52,13
5-9	19 680	19 847	19 992	20 086	20 007	19 308	18 833	18 315	17 734	17 133	16 294	-17,21
10-14	15 168	15 810	16 279	16 600	16 739	16 837	16 921	17 017	17 127	17 137	16 618	9,56
15-19	19 315	20 032	20 690	21 244	21 762	22 363	22 997	23 349	23 498	23 370	23 038	19,28
20-24	52 716	52 974	53 276	53 602	53 954	54 336	54 822	54 939	54 644	54 023	53 062	0,66
25-29	92 441	91 873	91 533	91 486	91 583	92 049	92 889	93 447	93 610	93 245	92 260	-0,20
30-34	109 423	110 043	110 594	111 156	111 411	112 043	113 460	115 138	116 857	118 348	119 364	9,08
35-39	98 654	100 499	101 992	103 489	104 473	106 127	109 358	113 363	117 598	121 682	125 275	26,98
40-44	70 979	73 065	75 274	77 855	80 231	83 344	86 891	91 346	96 436	101 984	107 809	51,89
45-49	46 189	49 441	52 188	54 474	55 974	57 444	60 277	64 164	68 950	74 535	80 844	75,03
50-54	27 730	29 316	30 827	32 364	33 712	35 470	38 740	42 333	46 118	49 969	53 728	93,75
55-59	16 444	17 408	18 327	19 272	20 058	20 998	22 462	24 339	26 585	29 210	32 241	96,07
60-64	9 848	10 374	10 873	11 396	11 832	12 363	13 195	14 252	15 511	16 960	18 596	88,83
65-69	5 947	6 242	6 520	6 807	7 041	7 326	7 779	8 353	9 032	9 812	10 690	79,75
70-74	3 685	3 837	3 980	4 128	4 248	4 403	4 653	4 965	5 328	5 736	6 185	67,84
75-79	1 965	2 035	2 101	2 169	2 223	2 299	2 427	2 591	2 783	2 999	3 236	64,68
80+	775	826	871	913	946	987	1 056	1 145	1 252	1 376	1 516	95,61
Total	616 030	628 176	639 046	649 536	657 457	666 528	683 387	703 077	725 537	748 948	772 755	25,44

III.1.2. Nouvelles infections à VIH par tranche d'âge

Le tableau 3 présente l'évolution du nombre de nouvelles infections par tranche d'âge, entre 2010 et 2020. Il ressort qu'entre 2016 et 2020, une baisse des nouvelles infections sera observée dans toutes les tranches d'âge sauf celle des 0 à 4 ans. Dans la population totale, la baisse passera de 48 263 en 2010 à 35 929 en 2020. Cette tendance suppose une accentuation spéciale des mesures de prévention telles que le « test and treat », le passage à échelle de l'option B+ et de la prise en charge du VIH pédiatrique, chez les populations hautement vulnérables ou les plus à risque

Tranche d'âge	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Taux moyen d'évolution entre 2010 et 2020 (en %)
0-4	8 527	8 938	8 670	7 923	7 540	4 915	4 405	3 314	3 329	3 413	3 835	55,03
5-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15-19	4 303	4 287	4 246	4 206	4 207	4 197	4 187	3 985	3 781	3 540	3 266	24,10
20-24	9 640	9 649	9 581	9 498	9 489	9 442	9 382	8 885	8 394	7 835	7 223	25,07
25-29	8 851	8 931	8 949	8 955	9 023	9 040	9 025	8 568	8 098	7 548	6 939	21,60
30-34	6 266	6 387	6 474	6 549	6 665	6 737	6 783	6 500	6 202	5 831	5 396	13,88
35-39	4 072	4 127	4 163	4 204	4 289	4 365	4 441	4 305	4 152	3 943	3 681	9,60
40-44	2 540	2 546	2 555	2 580	2 640	2 702	2 733	2 637	2 539	2 417	2 273	10,51
45-49	1 568	1 610	1 628	1 631	1 637	1 626	1 627	1 562	1 503	1 435	1 357	13,46
50-54	947	949	948	950	961	970	995	962	919	860	788	16,79
55-59	588	585	579	574	575	575	575	550	525	495	462	21,43
60-64	389	386	382	377	376	374	371	351	332	310	287	26,22
65-69	288	287	284	281	281	279	277	262	247	230	211	26,74
70-74	222	221	219	217	217	216	215	204	193	179	165	25,68
75-79	61	61	61	60	61	60	60	57	54	51	47	22,95
80+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	48 263	48 963	48 739	48 005	47 958	45 499	45 076	42 141	40 267	38 087	35 929	25,56

III.1.3. Prévalence du VIH dans la population de 15-49 ans

De manière générale, l'évolution de la prévalence du VIH dans la population des 15 à 49 ans va rester constante pour les années à venir. De 2010 à 2020, cette prévalence va diminuer progressivement sans pour autant être importante dans les deux sexes variant de 4,21% à 3,77% chez les hommes et 5,9% à 5,5% chez les femmes.

	Hommes (%)	Femmes (%)	Total (%)
2010	4,21	5,9	5,05
2011	4,15	5,83	4,99

2012	4,08	5,76	4,92
2013	3,99	5,72	4,85
2014	3,89	5,66	4,77
2015	3,83	5,6	4,71
2016	3,81	5,58	4,69
2017	3,8	5,57	4,68
2018	3,8	5,56	4,68
2019	3,79	5,54	4,66
2020	3,77	5,5	4,64

III.1.4. Besoins en TARV par tranche d'âge

Dans le tableau 5, est présentée l'évolution des besoins en TARV par tranche d'âge, entre 2010 et 2020. Mise à part, la tranche d'âge des 0-4 ans, les besoins en ARV vont aller croissant de 2016 à 2020 dans toutes les autres tranches d'âge. La tranche d'âge qui manifestera le plus de besoin en TARV sur cette même période sera celle des 35 à 39 ans ; suivi par les 30-34 ans et les 40-44 ans. Cela s'explique par le passage à l'échelle de l'option B+ et l'adoption du « test and treat » pour la majorité des groupes de la population générale. Il sera primordial de mettre un accent sur la prise en charge du VIH pédiatrique pour inverser la tendance présentée par ces chiffres

Tranche d'âge	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Taux moyen d'évolution entre 2010 et 2020 (en %)
0-4	20 388	19 263	18 195	16 672	15 512	14 143	12 826	11 988	11 359	11 315	13 101	-35,74
5-9	1 130	1 336	1 645	2 046	2 565	2 930	3 177	3 447	3 953	4 729	5 566	392,57
10-14	379	557	716	844	943	1 058	1 251	1 541	1 919	2 406	2 751	625,86
15-19	3 700	4 122	4 504	9 721	13 419	17 024	19 880	20 291	20 543	20 553	20 381	450,84
20-24	7 518	7 798	8 125	22 295	34 673	42 825	49 112	49 129	48 882	48 354	47 485	531,62
25-29	22 559	22 456	22 288	45 993	68 366	80 849	90 176	89 887	89 565	88 812	87 457	287,68
30-34	38 937	39 686	40 006	66 101	90 808	103 316	112 639	113 155	114 145	115 078	115 645	197,01

35-39	45 674	47 774	49 283	71 200	91 372	102 007	110 482	113 064	116 328	119 680	122 753	168,76
40-44	37 954	40 428	42 725	58 410	72 677	81 648	88 221	91 566	95 899	100 899	106 364	180,24
45-49	27 216	30 198	32 807	43 231	51 746	56 814	61 319	64 489	68 796	74 033	80 115	194,37
50-54	17 660	19 410	21 069	26 868	31 775	35 485	39 602	42 735	46 214	49 852	53 474	202,80
55-59	10 412	11 523	12 625	16 097	18 975	21 076	23 000	24 616	26 692	29 201	32 155	237,64
60-64	6 128	6 747	7 360	9 415	11 113	12 355	13 470	14 385	15 553	16 943	18 541	202,56
65-69	3 577	3 926	4 268	5 501	6 507	7 231	7 863	8 359	8 992	9 742	10 606	196,51
70-74	2 071	2 256	2 435	3 203	3 819	4 261	4 641	4 911	5 250	5 644	6 088	193,96
75-79	1 167	1 257	1 341	1 738	2 055	2 280	2 473	2 610	2 786	2 991	3 221	176,01
80+	561	618	671	821	943	1 030	1 109	1 184	1 281	1 398	1 534	173,44
Total	247 030	259 354	270 060	400 155	517 269	586 333	641 241	657 360	678 157	701 632	727 237	194,39

III.1.5. Décès liés au VIH/SIDA

En 2010, le nombre de personnes totales décédées liées au VIH/SIDA est estimé à 30 174 personnes, dont 56% de femmes. Un pic haut est observé en 2014 avec 34 158 personnes décédées dont 51% d'hommes. De 2014 à 2020, une baisse du nombre total des personnes décédées liées au VIH/SIDA est prévue jusqu'à atteindre 7 337 individus dont 51,82% de femmes. Cela s'expliquerait par l'amélioration de la prise en charge des PVVIH ainsi que leur qualité de vie.

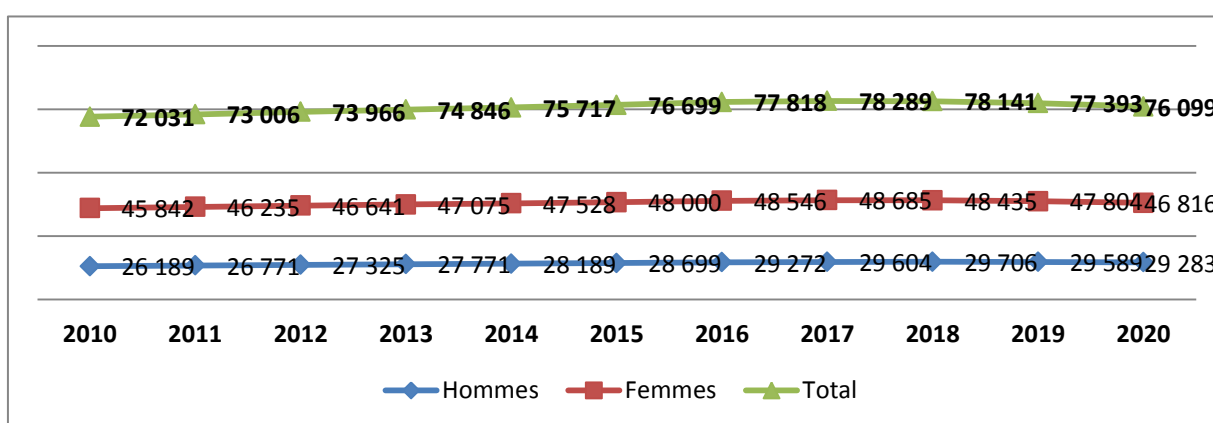
III. 2 Projections et estimations dans la population des 15 ans et plus de 2010 à 2020

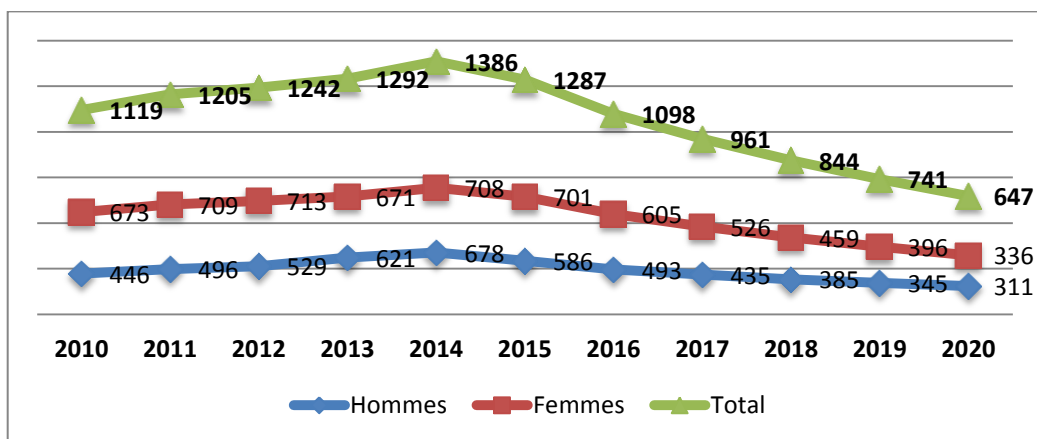
III.2.1. Nombre de PVVIH dans la tranche d'âge de 15-24 ans

Les estimations et projections de 2010 à 2020 ont montré une hausse progressive du nombre de PVVIH dans la tranche d'âge 15-24 ans, de 2010 à 2016, allant de 72 031 personnes (dont 63,64%) à 78 818 personnes. Après cette année, il y a une légère baisse de 2017 à 2020, de 78 289 personnes à 77 393 personnes (dont 61,77%). Cela suppose que des actions spécifiques de prévention et de prise en charge en direction de ce groupe doivent être menées.

III.2.2. Nombre de décès liés au VIH/SIDA (15-24 ans)

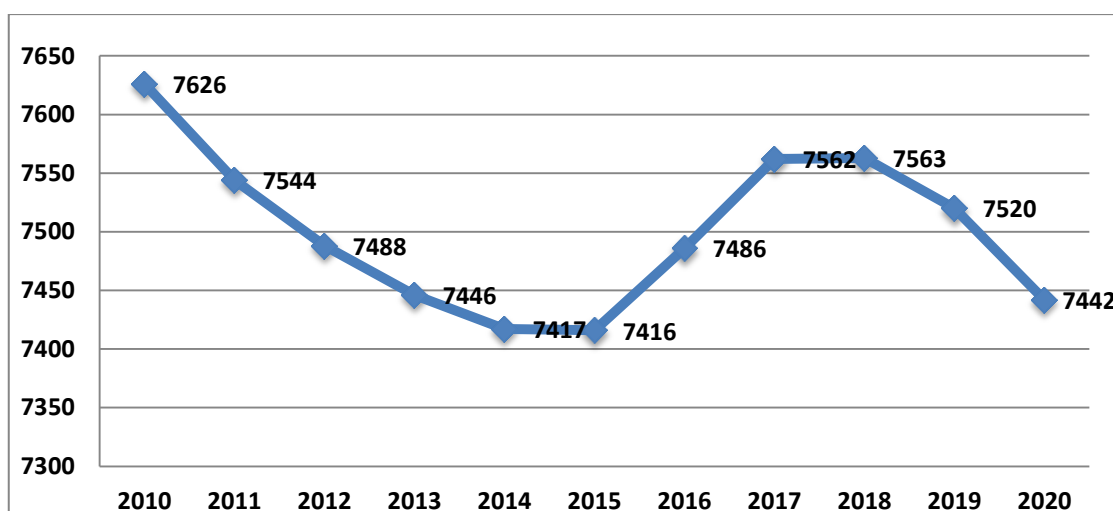
Sur toute la période allant de 2010 à 2020, les décès liés au VIH/SIDA dans la population féminine restent supérieurs à ceux dans la population masculine. Par ailleurs, il est observé une baisse progressive des décès jusqu'en 2020 allant de 1386 en 2014 à 647 décès attendus en 2020 dans cette tranche d'âge. Cela peut s'expliquer par les mesures de riposte en direction des 15 à 24 ans qui ont commencé à être implémentées dans les grandes villes à travers la prise en charge spécifique des adolescents dans les formations sanitaires.





III.2.3. Femmes enceintes séropositives âgées de 15 à 24 ans

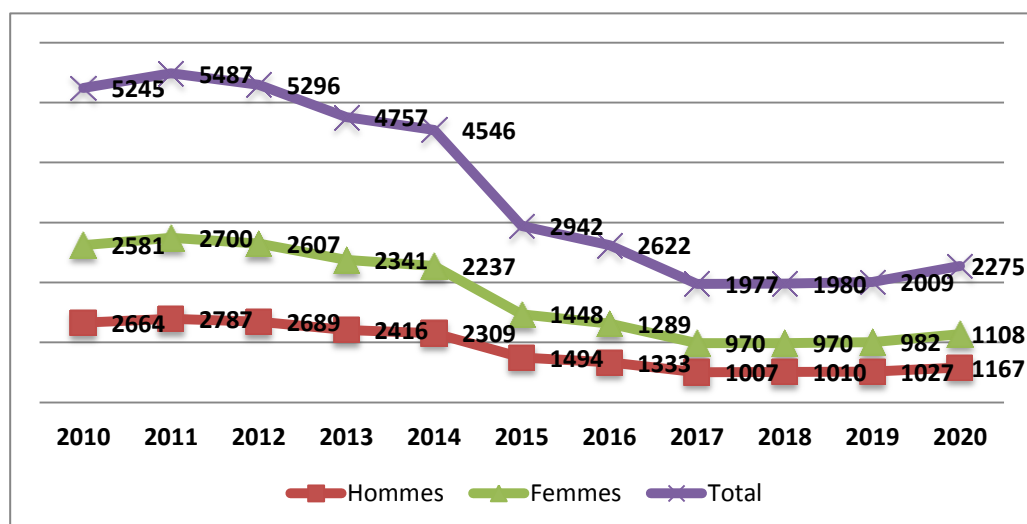
De 2010 à 2014, le nombre de femmes enceintes séropositives a baissé progressivement jusqu'en 2014. De 2015 à 2017, ce nombre va augmenter allant de 7416 PVVIH à 7562. Il est prévu une forte baisse à partir de cette année jusqu'en 2020.



III. 3 Projections et estimations chez les nourrissons de 2010 à 2020

III.3.1. Nombre de nourrissons atteints du VIH/SIDA

Globalement, les projections indiquent une tendance à la baisse du nombre d'enfants âgés de moins d'un an (2011-2017), même si une légère hausse est prévue entre 2018 et 2020. Sur toute la période, le nombre d'enfants âgés de moins d'un an de sexe masculin est supérieur à celui de sexe féminin. Cette tendance traduit l'ambition du pays de réduire les infections pédiatriques via la TME à moins de 5%.

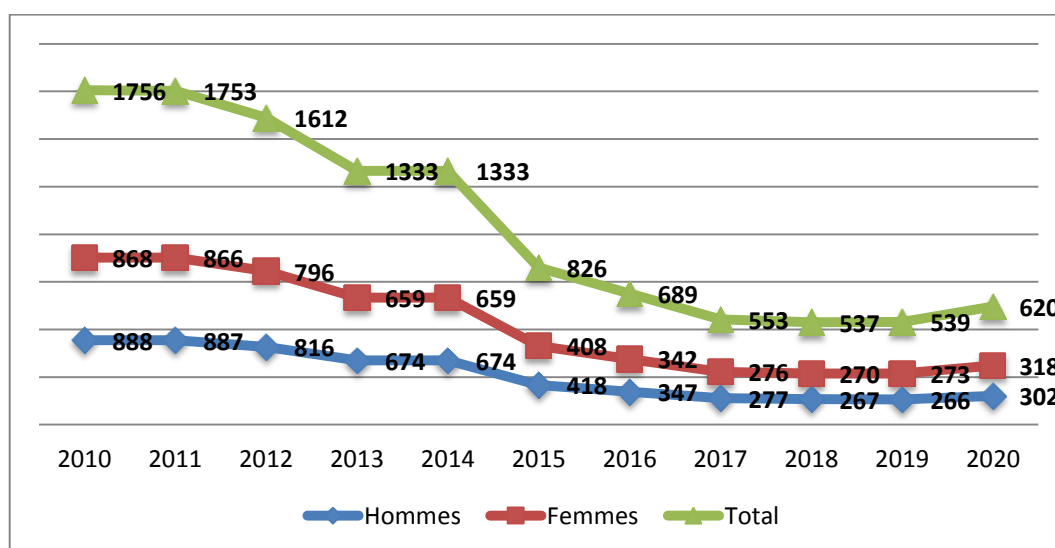


III.3.2. Nouvelles infections à VIH/SIDA chez les nourrissons

Entre 2010 et 2020, il est globalement observé une baisse en moyenne de 56,62% du nombre de nouvelles personnes âgées de moins d'un an et infectées par le VIH/SIDA. Cette tendance demeure la même indépendamment du sexe. Les efforts déployés par le pays pour lutter contre le VIH pédiatrique pourraient être à l'origine de la tendance évolutive de cette courbe. Figure 1: Evolution des nouveaux nourrissons infectés par le VIH/SIDA entre 2010 et 2020 par sexe

III.3.3. Décès des nourrissons liés au VIH/SIDA

Selon les estimations et projections de décès chez les nourrissons, le pays s'attend à une baisse de 66% en moyenne chez les nourrissons de sexe masculin et 63,36% chez ceux de sexe féminin. Et pour les deux sexes, il est prévu une baisse de 64,69% entre 2010 et 2020 allant de 1756 décès en 2010 à 620 en 2020.



III. 4. Projections et estimations pour la PTME de 2010 à 2020

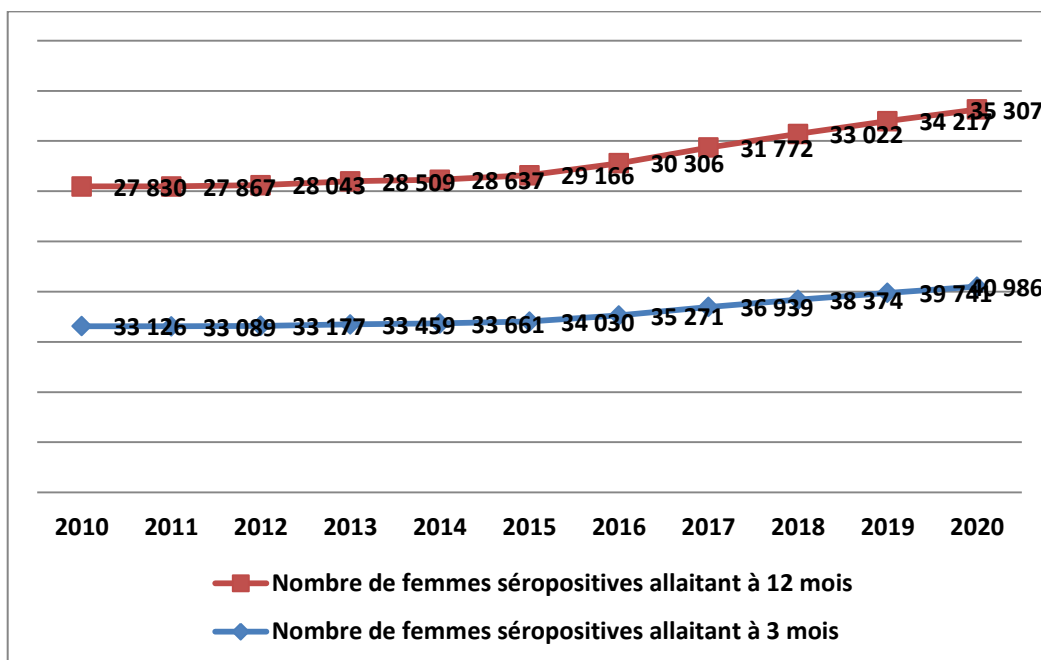
III.4.1. Option A et B+

De 2010 à 2013, le pays a appliqué principalement l'option A pour la prise en charge des femmes enceintes séropositives, c'est la raison pour laquelle les chiffres vont croissant. En 2014, le gouvernement a opté pour l'application progressive de l'option B+ (ART commencé pendant la grossesse en cours > 4 semaines avant l'accouchement) en même temps que se fait la sortie progressive de l'option A pour 2016. Les hypothèses de progression de la PTME, de 2015 à 2020, indiquent une hausse constante du nombre de femmes enceintes ayant débuté les ARV avant la grossesse en cours pour atteindre 33 094 sous ARV pour la PTME. Tandis que le nombre de femmes à mettre sous ARV au cours de la grossesse va décroître jusqu'en 2020.

Globalement, 33 094 femmes enceintes séropositives ayant débuté les ARV avant la grossesse en cours auront besoin de la PTME, entre 2015 et 2020.

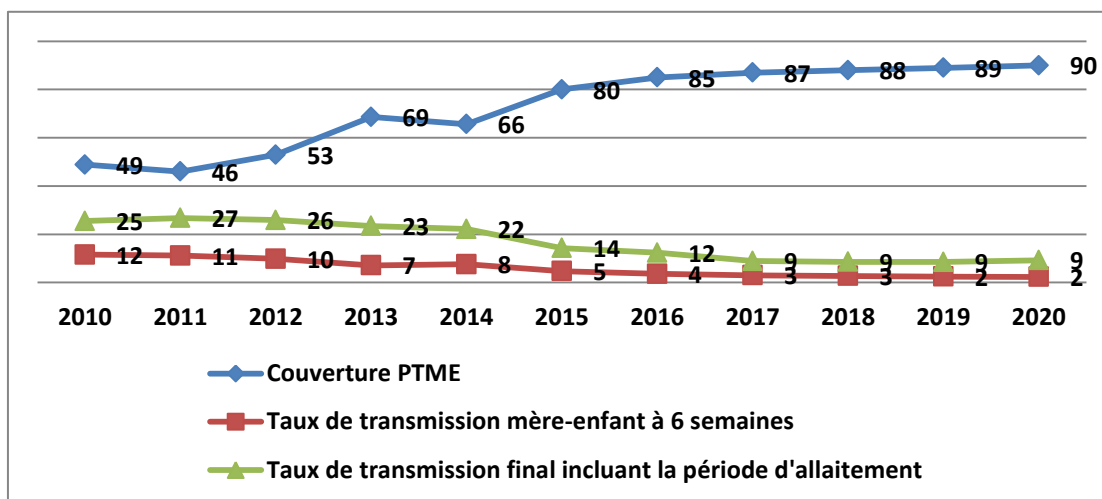
III.4.2. Nombre de femmes séropositives allaitant à 3 et 12 mois.

La tendance des courbes montre une évolution croissante du nombre de femmes séropositives allaitant à 3 mois et 12 mois entre 2014 et 2020. L'adhérence des femmes séropositives à la PTME sur l'étendue du territoire justifierait cette tendance. En moyenne, il y a un taux d'accroissement de 23,73% chez celles de la catégorie allaitant à 3 mois et 26,87% chez celles de la catégorie allaitant à 12 mois entre 2010 et 2020.



III.4.3. Couverture PTME, Taux de transmission mère-enfant à 6 semaines, taux de transmission final incluant la période d'allaitement

La couverture PTME, d'après les estimations et les prévisions, est croissante depuis 2010 et continuera de croître pour atteindre 90% en 2020. En moyenne, le taux d'accroissement est de 84,31%. Par ailleurs, le taux de transmission mère-enfant à 6 semaines, quant à lui verra sa courbe, jusqu'ici stable, décroître de 2014 jusqu'en 2017 puis se stabilisera à 9%.



III.4.4. Nombre de nouvelles infections chez les enfants dues à la transmission de la mère à l'enfant

Le nombre total de ces nouvelles infections (hommes et femmes), entre 2010 et 2020 est en baisse en moyenne à taux de 55,01%, allant de 8527 à 3836 nouveaux

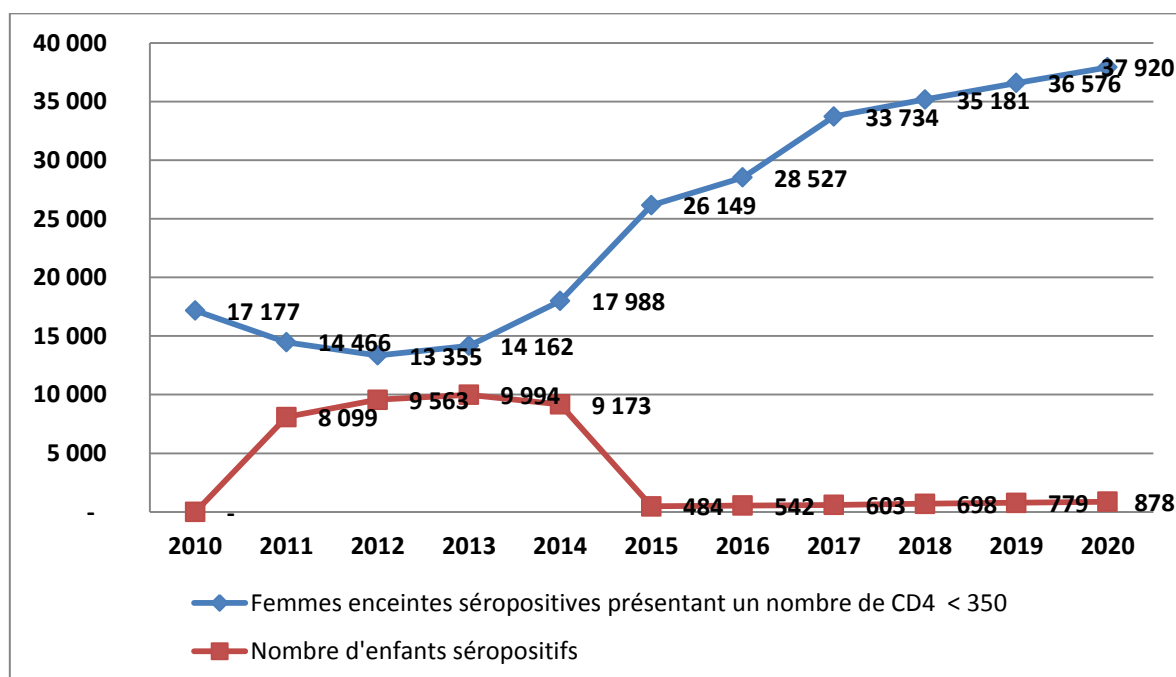
nourrissions infectés. Cette réduction de cas est probablement due et le restera si la prise en charge des femmes enceintes (Option B+) continue d'être bien mise en œuvre.

De manière plus détaillé, chez les enfants du sexe masculin, une baisse en moyenne de 55,03% est observée par an entre 2010 et 2020 ; chez les nourrissons de sexe féminin, la baisse est en moyenne de 54,99% par an.

Année	Total	Hommes	Femmes
2010	8527	4321	4206
2011	8938	4529	4409
2012	8670	4393	4277
2013	7923	4014	3909
2014	7540	3820	3720
2015	4915	2490	2425
2016	4406	2232	2174
2017	3314	1679	1635
2018	3328	1686	1642
2019	3413	1729	1684
2020	3836	1943	1893
Taux moyen d'évolution (en %)	-55,01	-55,03	-54,99

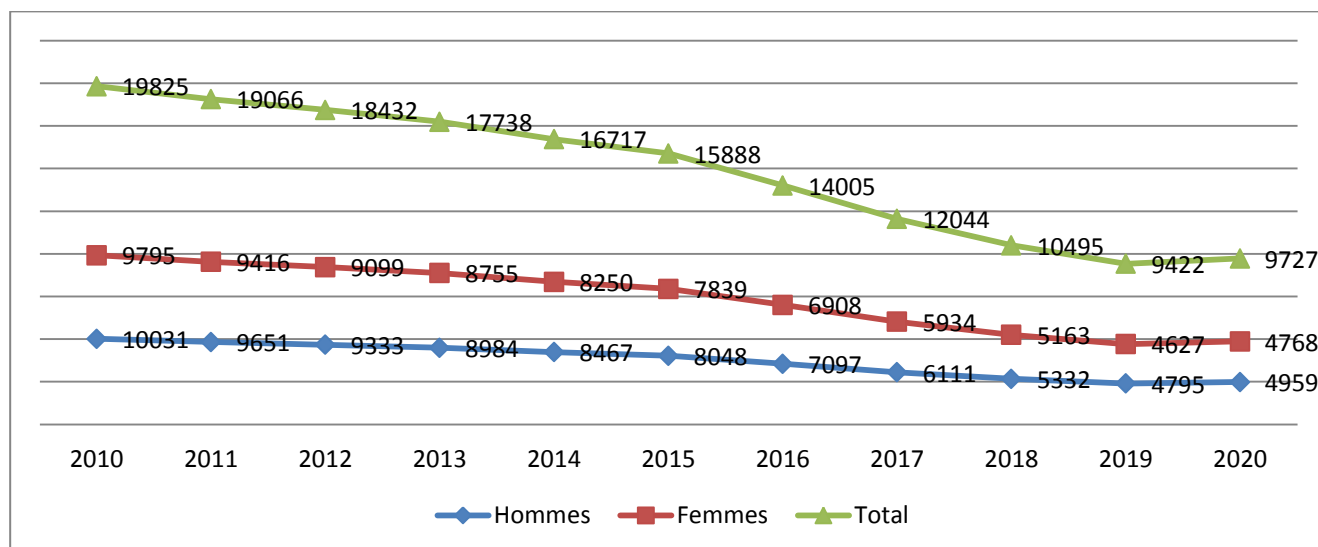
III. 4.5. Femmes enceintes séropositives présentant un nombre de CD4< 350, nombre d'enfants séropositifs

Le graphique 14 montre l'évolution de ces deux indicateurs. Le premier présente une allure descendante entre 2010 et 2012 (passant de 17 177 à 13 355 individus). Après, de 2012 à 2020, cette allure est plutôt ascendante passant de 13355 à 37920 individus. Le second indicateur, à savoir le nombre d'enfants séropositifs présente quant à lui une allure contraire au premier. Cette allure est marquée par une hausse entre 2010 et 2013 (passant de 0 à 9894 individus). Après, on prévoit entre 2013 à 2020, une baisse passant de 9894 à 878 individus.



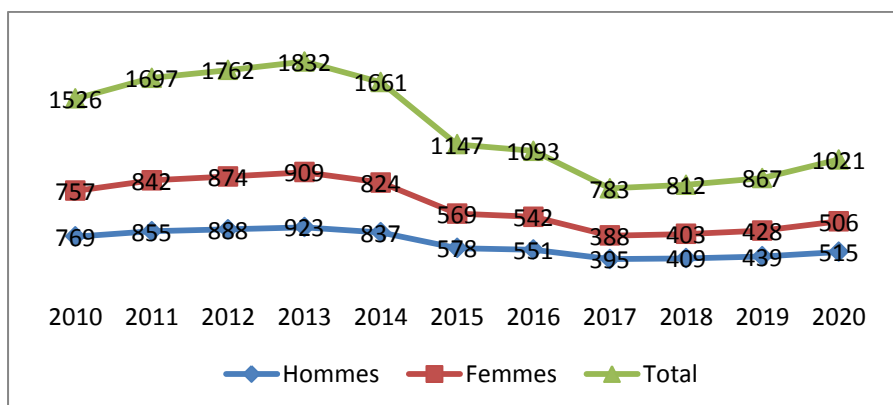
III.4.6. Population totale des enfants âgés de 1 à 4 ans

Dans la population des enfants de 1 à 4 ans, les filles sont plus infectées que les garçons. Le tableau ci-dessous, d'ici 2020, montre une diminution de près de 50% d'enfants infectés dans la tranche d'âge de 1 à 4 ans. Cette diminution se fera de manière progressive. Ainsi, elle passera de 19 825 en 2010 à 9 727 en 2020. Dès 2016, la courbe de cette population pour les deux sexes sera constante. La transmission du VIH dans cette population étant essentiellement verticale, il est donc primordial de suivre et d'évaluer les stratégies actuelles mises en œuvre pour cette cible.



III.4.8. Nouvelles infections chez les PVVIH âgées de 1 à 4 ans

De même que le graphique précédent, les nouvelles infections restent élevées. De manière générale, la courbe des nouvelles infections dans cette tranche d'âge est assez discontinue. Pourtant on observe que chez les garçons depuis 2015, cette courbe est constante. Toutefois, entre 2017 et 2019, ces infections vont diminuer dans l'ensemble. Elles passeront de 783 en 2017, 812 en 2018 et 864 en 2019. puis dès 2020 on observera une augmentation. Soit 1021 nouvelles infections.



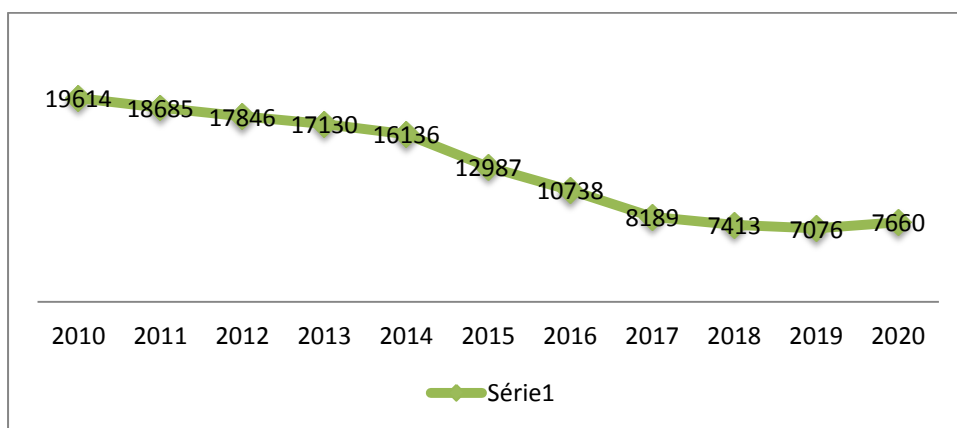
III.4.9. Décès dus au VIH dans la population de 1 à 4 ans

D'après les estimations et projections suivantes, les décès dus au VIH chez les enfants de 1 à 4 ans vont diminuer au fil des années. Dès 2017, le nombre total de ces décès va être de 944 décès par an. Soit une diminution par rapport à 2010 de plus de 60%. En 2020, seulement 524 décès par an seront enregistrés dans la population totale et voire zéro décès dû au VIH chez les enfants de un à quatre

ans. D'où la nécessité de redoubler d'efforts dans la prise en charge des femmes enceintes.

III.4.10. Enfants VIH+ âgés de moins de 2 ans

Durant la période de 2010 à 2015, le nombre d'enfants VIH + âgés de moins de 2 ans infectés par le VIH observe une diminution de plus de 30% jusqu'à atteindre les 60% en 2020.



III.5. Récapitulatifs des impacts

D'après les estimations et projections faites jusqu'en 2020, une bonne mise en œuvre des mécanismes de prévention tant dans la population générale que chez les femmes enceintes en particulier permettra d'augmenter le nombre d'années de vie grâce à la TAR et à la PTME. Par ricochet, elle permettra de diminuer le nombre de décès dû à l'infection au VIH.

	Nombre de décès évités par TAR	Infections évitées par PTME	Années de vie gagnées grâce à TAR et PTME	Décès évités grâce à l'ART (0-4)	Décès évités grâce au cotrimoxazole (0-4)	Décès évités grâce au PMTCT (0-4)
2010	11 725	3 296	60 938	-37	87	1 315
2011	10 308	2 868	74 634	20	90	1 651
2012	9 735	3 028	87 720	44	97	1 808
2013	10 050	3 892	101 542	28	105	2 222
2014	7 521	4 601	113 314	26	117	2 541
2015	10 751	7 478	128 932	-128	239	3 268
2016	18 266	8 594	152 692	-346	538	3 840
2017	23 620	10 458	182 440	-355	818	4 105
2018	27 608	11 341	217 156	-351	1 113	4 303
2019	30 733	12 750	255 362	-478	1 485	4 524
2020	32 995	16 240	296 438	-1 062	2 210	5 163

III.6. Orphelins du SIDA

Dans l'ensemble, le nombre d'orphelins dû au SIDA est régulier. Le nombre d'orphan toutes causes confondus reste largement supérieur au nombre des orphelins du SIDA. Cependant, le nombre d'orphelins de père est supérieur au nombre d'orphan de mère et supérieur au nombre d'orphelins de père et de mère décédés à cause du SIDA.

Année	Orphelins de mère			Orphelins de père			Orphelins de père et de mère			Total orphelins	Tous orphelins du SIDA
	SIDA	Non SIDA	Total	SIDA	Non SIDA	Total	SIDA	Non SIDA	Total		
2010	147 396	345 843	493 239	230 668	628 700	859 368	95 392	99 902	195 294	1 157 313	299 601
2011	148 719	349 972	498 690	232 117	635 840	867 958	96 024	100 746	196 770	1 169 878	301 708
2012	149 920	354 025	503 944	233 452	642 891	876 344	96 368	101 485	197 853	1 182 435	303 856
2013	148 629	357 988	506 617	239 349	649 890	889 239	96 530	102 112	198 642	1 197 214	308 254
2014	145 942	361 805	507 748	245 593	656 692	902 286	96 124	102 662	198 786	1 211 248	312 097
2015	146 036	365 362	511 398	253 231	663 054	916 284	96 743	102 912	199 656	1 228 027	319 286
2016	144 449	368 574	513 022	250 584	668 920	919 505	95 101	103 260	198 361	1 234 166	316 335
2017	136 985	371 439	508 424	240 391	674 302	914 694	90 347	103 897	194 244	1 228 873	302 496
2018	127 225	373 951	501 176	225 602	679 210	904 811	84 199	104 762	188 961	1 217 026	282 897
2019	115 913	376 126	492 039	207 885	683 702	891 588	77 061	105 669	182 729	1 200 897	259 656
2020	103 819	377 983	481 802	188 562	687 836	876 398	69 554	106 782	176 336	1 181 864	234 329

IV - CONCLUSION

Suivant la dynamique de l'épidémie, les décisions stratégiques prises par le pays et les résultats des opérations menées, les tendances des projections peuvent varier. Ce document avait pour objectif de présenter le profil 2015 des estimations et projections pays au Cameroun.

Les tendances actuelles nous montrent que les populations les plus infectées se trouvent dans la tranche d'âge des 30 à 34 ans. Le nombre de PVVIH de moins de 15 ans connaîtra une éventuelle diminution et passera d'environ 59 918 en 2010 à 49 914 en 2020. Entre 2010 et 2020, on observera une diminution du nombre de nouvelles infections au VIH dans la population générale passant d'environ 48 263 à 35 929 personnes nouvellement infectées. En outre, on observe une tendance à la baisse de la prévalence évaluée en 2011 à 4,3% par l'EDS. Elle est estimée actuellement à 4,71% et cette baisse pourra atteindre 4,64% en 2020 ; ceci grâce à une baisse de l'incidence estimée actuellement à 0,37, qui si les mesures de prévention envisagées sont effectives descendra à 0,25 en 2020. Le nombre de décès et le taux de mortalité chez les PVVIH diminueront et cette diminution pourra vers 2020 voir remonter progressivement le nombre de PVVIH.

L'impact des efforts de prévention et de traitement envisagés en 2014 est évident. Le défi sera pour le pays d'opérationnaliser ces décisions pour que soient effectives ces tendances globalement positives.

BIBLIOGRAPHIE

1-	CNLS Cameroun, Profil des Estimations et projections en matière de VIH/sida au Cameroun, (Editions 2007, 2008,2009, 2010, 2011,2012, 2013)
2-	CNLS-Cameroun: Plan Stratégique de lutte contre le SIDA 2014-2017 ; CNLS 2014
3-	CNLS : Rapport annuel CNLS 2014, CNLS 2015
4-	CNLS : Rapport de Progrès Vers l'Accès Universel aux traitements et soins CNLS N° 2 – 12
5-	CNLS : Rapport de Progrès PTME CNLS N° 1-5
6-	INS : Enquête camerounaise auprès des ménages, 2001, 2004
7-	INS : Annuaire Statistique, 2006, 2008
8-	MINE PAT /BUCREP : Rapport provisoire du Recensement Général de la Population et de l'Habitat au Cameroun, 2005.
9-	MINE PAT /BUCREP : Rapport du Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 1987
10-	MIN SANTÉ /CHP : Cartographie des Travailleurs du Sexe, 2008
11-	MIN SANTÉ-INS : EDS-MICS 2011
12-	MIN SANTE/CRETES : Enquête séro-épidémiologique et comportementale dans les groupes spécifiques, 2012
13-	ONU SIDA : Rapport mondial sur l'épidémie de sida 2014,

ANNEXE : Liste des personnes ayant contribué à la production de ce rapport

Coordination

- Dr ELAT NFETAM Jean Bosco ; SP/GTC/CNLS
- Dr Amadou Moctar MBAYE ; Coordonateur pays ONUSIDA
- Dr IBILE ABESSOUGUIE ; SPA/GTC/CNLS

Equipe de rédaction

- Dr BILLONG Serge ; CSPSE/GTC/CNLS
- Dr NGO NEMB TCHATO MARINETTE, Cadre SASS/GTC/CNLS
- Mme MESSEH LIENOU Arlette ; Cadre SPSE/GTC/CNLS ;
- M. FODJO TOUKAM Raoul ; Cadre SPSE/GTC/CNLS ;
- Dr Gatien K. EKANMIAN, ONUSIDA

TABLEAUX AVEC ANALYSE DES INCERTITUDES

ANALYSE DES INCERTITUDES

1. Nombre total des nouvelles infections

	Inférieur 2,50%	Moyen 50%	Supérieur 97,50%
2010	43 047	48 263	53 210
2011	43 294	48 963	54 435
2012	42 389	48 739	54 846
2013	41 488	48 005	54 411
2014	40 906	47 958	55 194
2015	38 265	45 499	52 953
2016	37 220	45 076	53 360
2017	33 952	42 141	50 690
2018	31 938	40 267	49 767
2019	30 069	38 087	48 020
2020	27 773	35 929	46 271

2. Total adultes et enfants VIH+

	Inférieur 2,50%	Moyen 50%	Supérieur 97,50%
2010	576 185	616 030	653 165
2011	584 259	628 176	777 307
2012	593 230	639 046	780 930
2013	602 466	649 536	784 519
2014	608 884	657 457	786 350
2015	615 621	666 528	786 674
2016	628 660	683 387	795 438
2017	645 036	703 077	810 170
2018	662 931	725 537	830 019

2019	681 558	748 948	847 195
2020	699 549	772 755	868 475

3. Total annuel des décès liés au SIDA

	Inférieur 2,50%	Moyen 50%	Supérieur 97,50%
2010	12 504	30 174	37 115
2011	27 252	31 635	66 578
2012	27 132	32 332	52 439
2013	26 542	31 787	46 865
2014	28 341	34 158	49 721
2015	23 131	30 711	43 445
2016	16 376	22 818	33 187
2017	12 268	17 173	25 161
2018	9 234	12 999	19 071
2019	6 695	9 742	14 442
2020	4 964	7 336	11 158

4. Nouvelles infections au VIH des PVVIH âgées de 15 ans et plus

	Inférieur 2,50%	Moyen 50%	Supérieur 97,50%
2010	34 995	39 735	44 373
2011	34 836	40 026	44 977
2012	34 393	40 068	45 390
2013	34 043	40 082	45 712
2014	33 999	40 418	46 688

2015	33 812	40 584	47 446
2016	33 283	40 671	48 550
2017	30 990	38 827	47 088
2018	28 897	36 939	46 165
2019	26 892	34 674	44 315
2020	24 483	32 094	42 053

5. Décès annuel du au VIH chez les 15 ans et plus

	Inférieur 2,50%	Moyen 50%	Supérieur 97,50%
2010	-732	24 495	34 463
2011	19 651	26 322	83 221
2012	18 813	27 226	65 068
2013	19 553	27 087	51 059
2014	21 287	29 711	55 603
2015	18 397	26 930	41 205
2016	13 221	19 672	30 145
2017	9 752	14 456	22 120
2018	7 172	10 638	16 222
2019	5 027	7 621	11 632
2020	3 478	5 328	8 358

6. Population de VIH des enfants

	Inférieur 2,50%	Moyen 50%	Supérieur 97,50%
2010	55 627	59 918	64 692
2011	55 919	60 211	64 966
2012	55 815	60 000	64 831
2013	54 666	59 181	64 138
2014	53 495	58 009	63 047
2015	50 894	54 976	59 661
2016	48 379	52 381	56 864
2017	45 569	49 354	53 927
2018	43 577	47 337	51 975
2019	41 843	45 701	50 330
2020	40 873	44 913	49 502

7. Nouvelles infections à VIH chez les enfants

	Inférieur 2,50%	Moyen 50%	Supérieur 97,50%
2010	7 421	8 527	9 780
2011	7 802	8 938	10 242
2012	7 501	8 670	10 012
2013	6 750	7 923	9 375
2014	6 360	7 540	8 800
2015	4 362	4 915	5 508
2016	3 905	4 405	4 929
2017	2 958	3 314	3 699
2018	2 941	3 329	3 755

2019	2 957	3 413	3 913
2020	3 254	3 835	4 470

8. Décès annuel liés au SIDA chez les enfants

	Inférieur 2,50%	Moyen 50%	Supérieur 97,50%
2010	5 173	5 679	6 286
2011	4 819	5 313	5 939
2012	4 603	5 106	5 731
2013	4 211	4 700	5 297
2014	3 971	4 447	5 060
2015	3 409	3 780	4 222
2016	2 847	3 146	3 477
2017	2 471	2 717	2 994
2018	2 112	2 361	2 633
2019	1 856	2 120	2 392
2020	1 709	2 008	2 334

9. Besoin de thérapie ARV chez les enfants

	Inférieur 2,50%	Moyen 50%	Supérieur 97,50%
2010	26 451	28 796	31 406
2011	26 188	28 344	31 241
2012	25 356	27 674	30 521
2013	24 385	26 781	29 739
2014	23 353	25 667	28 449
2015	21 870	23 862	26 334

2016	19 581	21 495	23 581
2017	17 849	19 680	21 646
2018	17 233	19 121	21 116
2019	17 805	19 842	22 125
2020	18 352	20 570	23 052

10. Décès annuels dus au SIDA chez les enfants de 1-4 ans

	Inférieur 2,50%	Moyen 50%	Supérieur 97,50%
2010	2 206	2 453	2 730
2011	1 844	2 066	2 317
2012	1 770	1 987	2 257
2013	1 639	1 860	2 127
2014	1 403	1 621	1 897
2015	1 304	1 530	1 792
2016	1 002	1 135	1 283
2017	841	944	1 051
2018	628	714	804
2019	509	584	666
2020	440	524	622

11. Nouvelles infections à VIH chez les Hommes de 15 à 24 ans

	Inférieur 2,50%	Moyen 50%	Supérieur 97,50%
2010	3 693	5 007	6 170
2011	3 694	5 001	6 310
2012	3 655	4 958	6 221
2013	3 517	4 908	6 166
2014	3 539	4 899	6 295
2015	3 496	4 873	6 424
2016	3 503	4 843	6 393
2017	3 205	4 588	6 172
2018	2 951	4 335	6 057
2019	2 723	4 046	5 731
2020	2 493	3 727	5 411

12. Nouvelles infections à VIH chez les Femmes de 15 à 24 ans

	Inférieur 2,50%	Moyen 50%	Supérieur 97,50%
2010	7 741	8 936	10 213
2011	7 694	8 934	10 264
2012	7 560	8 870	10 271
2013	7 314	8 796	10 247
2014	7 320	8 796	10 404
2015	7 156	8 766	10 468
2016	7 101	8 726	10 584

2017	6 492	8 282	10 280
2018	6 128	7 840	9 929
2019	5 630	7 329	9 525
2020	5 124	6 762	8 978

13. Décès annuels liés au SIDA chez les adultes de 15 à 24 ans

	Inférieur 2,50%	Moyen 50%	Supérieur 97,50%
2010	1 138	1 119	1 987
2011	759	1 205	7 809
2012	704	1 241	5 994
2013	797	1 292	4 172
2014	891	1 386	3 244
2015	913	1 287	2 253
2016	774	1 097	1 682
2017	671	961	1 437
2018	582	845	1 240
2019	497	740	1 093
2020	430	647	958

14. Mères ayant besoin de PTME

	Inférieur 2,50%	Moyen 50%	Supérieur 97,50%
2010	30 201	33 466	37 034
2011	30 201	33 426	37 216
2012	30 183	33 510	37 177
2013	30 462	33 784	37 494
2014	30 542	33 990	37 444
2015	30 770	34 353	37 874
2016	32 126	35 602	39 301
2017	33 729	37 284	41 171
2018	34 964	38 731	42 882
2019	35 559	40 111	44 675
2020	36 421	41 367	46 379

15. Orphelins du SIDA

	Inférieur 2,50%	Moyen 50%	Supérieur 97,50%
2010	137 719	299 449	906 152
2011	186 847	301 556	768 566
2012	197 636	303 703	738 032
2013	204 730	308 099	706 330
2014	210 462	311 940	689 131
2015	222 760	319 126	671 221
2016	230 023	316 178	567 967
2017	217 662	302 350	476 908
2018	199 389	282 766	418 359

2019	178 640	259 544	374 731
2020	157 642	234 239	335 300

16. Tableau récapitulatif, estimations de l'année 2015

	Inférieur 2,50%	Moyen 50%	Supérieur 97,50%
Adultes + enfants VIH	615 621	666 528	786 674
Total number of new HIV infections	38 265	45 499	52 953
Total annual AIDS deaths	23 131	30 711	43 445
Prévalence du VIH: adultes 15-49 ans	4,36	4,71	5,04
Incidence du VIH: adultes 15-49 ans	0,31	0,37	0,43
Population VIH+ (15-49)	488 590	527 705	564 869
Adultes 15+ VIH	563 871	611 552	726 567
Femmes 15+ VIH	330 316	359 626	416 771
Nouvelles infections VIH: adultes 15+	33 812	40 584	47 446
Décès annuels dus au SIDA: adultes 15+	18 397	26 930	41 205
Besoin de thérapie ARV: adultes 15+ (Déc. 31)	539 021	584 200	706 298
Population VIH: enfants	50 894	54 976	59 661
Nouvelles infections VIH: enfants	4 362	4 915	5 508
Décès annuels dus au SIDA: enfants	3 409	3 780	4 222
Besoin de thérapie ARV: enfants (Déc. 31)	21 870	23 862	26 334
Décès annuels dus au sida: enfants (1-4)	1 304	1 530	1 792
Prévalence du VIH: hommes 15-24	0,87	1,22	1,76
Prévalence du VIH: femmes 15-24	1,77	2,06	2,56
Nouvelles infections à VIH: hommes 15-24	3 496	4 873	6 424
Nouvelles infections à VIH: femmes 15-24	7 156	8 766	10 468
Décès annuels liés au sida: adultes 15-24	913	1 287	2 253

Population VIH+ 10-19	33 726	39 200	46 011
Nouveaux cas de VIH 10-19	2 610	4 197	6 328
Décès annuels dus au SIDA 10-19	1 143	1 291	1 461
Mères ayant besoin de PTME	30 770	34 353	37 874
Orphelins du SIDA	222 760	319 126	671 221

ANNEXES

Tableau récapitulatif

TABLEAU RECAPITULATIF ELARGI

	Total adulte et enfant VIH	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Inférieur 2,50%	576 185	584 259	593 230	602 466	608 884	615 621	628 660	645 036	662 931	681 558	699 549
	Moyen 50%	616 030	628 176	639 046	649 536	657 457	666 528	683 387	703 077	725 537	748 948	772 755
	Supérieur 97,50%	653 165	777 307	780 930	784 519	786 350	786 674	795 438	810 170	830 019	847 195	868 475
	Nombre total des nouvelles infections	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Inférieur 2,50%	43 047	43 294	42 389	41 488	40 906	38 265	37 220	33 952	31 938	30 069	27 773
	Moyen 50%	48 263	48 963	48 739	48 005	47 958	45 499	45 076	42 141	40 267	38 087	35 929
	Supérieur 97,50%	53 210	54 435	54 846	54 411	55 194	52 953	53 360	50 690	49 767	48 020	46 271
	Total annuel des décès lié au SIDA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Inférieur 2,50%	12 504	27 252	27 132	26 542	28 341	23 131	16 376	12 268	9 234	6 695	4 964

3	Moyen 50%	30 174	31 635	32 332	31 787	34 158	30 711	22 818	17 173	12 999	9 742	7 336
	Supérieur 97,50%	37 115	66 578	52 439	46 865	49 721	43 445	33 187	25 161	19 071	14 442	11 158

4	Prévalence du VIH: adultes 15-49 ans	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Inférieur 2,50%	4,76	4,7	4,62	4,54	4,44	4,36	4,32	4,3	4,26	4,22	4,15
	Moyen 50%	5,05	4,99	4,92	4,85	4,77	4,71	4,69	4,68	4,68	4,66	4,64
	Supérieur 97,50%	5,33	5,29	5,22	5,17	5,09	5,04	5,04	5,06	5,09	5,12	5,13

5	Incidence du VIH: adultes 15-49 ans	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Inférieur 2,50%	0,37	0,36	0,34	0,33	0,32	0,31	0,29	0,27	0,24	0,22	0,19
	Moyen 50%	0,42	0,41	0,4	0,39	0,38	0,37	0,36	0,33	0,31	0,28	0,25
	Supérieur 97,50%	0,46	0,46	0,45	0,44	0,43	0,43	0,42	0,4	0,38	0,35	0,33

6	Population VIH+ (15-49)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Inférieur 2,50%	460 942	468 326	474 595	479 575	483 597	488 590	498 768	509 550	521 526	531 777	539 012
	Moyen 50%	489 717	497 927	505 547	513 306	519 388	527 705	540 694	555 746	571 593	587 186	601 651

	Supérieur 97,50%	516 016	527 888	536 964	546 804	553 954	564 869	580 817	600 771	621 996	645 571	665 069
7	Adultes 15+ VIH	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Inférieur 2,50%	518 560	527 342	536 564	546 367	554 277	563 871	579 945	599 183	619 078	639 700	657 845
	Moyen 50%	556 111	567 965	579 046	590 355	599 448	611 552	631 006	653 723	678 201	703 247	727 842
	Supérieur 97,50%	591 896	709 964	714 152	718 068	722 953	726 567	738 262	755 468	780 750	797 264	822 151
8	Femmes 15+ VIH	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Inférieur 2,50%	298 676	302 555	308 653	317 165	323 176	330 316	340 744	352 711	364 583	376 077	387 372
	Moyen 50%	320 719	327 652	334 529	343 753	351 679	359 626	371 377	384 822	399 130	413 715	428 044
	Supérieur 97,50%	342 965	397 748	398 663	406 436	413 513	416 771	426 814	439 875	453 088	468 289	483 592
9	Nouvelles infections VIH: adultes 15+	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Inférieur 2,50%	34 995	34 836	34 393	34 043	33 999	33 812	33 283	30 990	28 897	26 892	24 483
	Moyen 50%	39 735	40 026	40 068	40 082	40 418	40 584	40 671	38 827	36 939	34 674	32 094
	Supérieur 97,50%	44 373	44 977	45 390	45 712	46 688	47 446	48 550	47 088	46 165	44 315	42 053
	Décès annuels dus au	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

SIDA: adultes 15+												
10	Inférieur 2,50%	-732	19 651	18 813	19 553	21 287	18 397	13 221	9 752	7 172	5 027	3 478
	Moyen 50%	24 495	26 322	27 226	27 087	29 711	26 930	19 672	14 456	10 638	7 621	5 328
	Supérieur 97,50%	34 463	83 221	65 068	51 059	55 603	41 205	30 145	22 120	16 222	11 632	8 358
Besoin de thérapie ARV: adultes 15+ (Déc. 31)												
11	Inférieur 2,50%	210 178	212 096	222 607	364 562	471 880	539 021	590 756	607 675	625 253	643 729	659 976
	Moyen 50%	239 419	250 734	261 221	395 392	511 190	584 200	642 424	663 052	685 407	708 118	729 960
	Supérieur 97,50%	266 516	701 734	688 603	582 426	660 036	706 298	749 509	765 732	789 242	803 136	824 600
Population VIH: enfants												
12	Inférieur 2,50%	55 627	55 919	55 815	54 666	53 495	50 894	48 379	45 569	43 577	41 843	40 873
	Moyen 50%	59 918	60 211	60 000	59 181	58 009	54 976	52 381	49 354	47 337	45 701	44 913
	Supérieur 97,50%	64 692	64 966	64 831	64 138	63 047	59 661	56 864	53 927	51 975	50 330	49 502
13	Nouvelles infections	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

	VIH: enfants											
	Inférieur 2,50%	7 421	7 802	7 501	6 750	6 360	4 362	3 905	2 958	2 941	2 957	3 254
	Moyen 50%	8 527	8 938	8 670	7 923	7 540	4 915	4 405	3 314	3 329	3 413	3 835
	Supérieur 97,50%	9 780	10 242	10 012	9 375	8 800	5 508	4 929	3 699	3 755	3 913	4 470
14	Décès annuels dus au SIDA: enfants											
	Inférieur 2,50%	5 173	4 819	4 603	4 211	3 971	3 409	2 847	2 471	2 112	1 856	1 709
	Moyen 50%	5 679	5 313	5 106	4 700	4 447	3 780	3 146	2 717	2 361	2 120	2 008
	Supérieur 97,50%	6 286	5 939	5 731	5 297	5 060	4 222	3 477	2 994	2 633	2 392	2 334
15	Besoin de thérapie ARV: enfants (Déc. 31)											
	Inférieur 2,50%	26 451	26 188	25 356	24 385	23 353	21 870	19 581	17 849	17 233	17 805	18 352
	Moyen 50%	28 796	28 344	27 674	26 781	25 667	23 862	21 495	19 680	19 121	19 842	20 570
	Supérieur 97,50%	31 406	31 241	30 521	29 739	28 449	26 334	23 581	21 646	21 116	22 125	23 052
16	Décès annuels dus au sida: enfants (1-4)											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

Inférieur 2,50%	2 206	1 844	1 770	1 639	1 403	1 304	1 002	841	628	509	440
Moyen 50%	2 453	2 066	1 987	1 860	1 621	1 530	1 135	944	714	584	524
Supérieur 97,50%	2 730	2 317	2 257	2 127	1 897	1 792	1 283	1 051	804	666	622

17	Prévalence du VIH: hommes 15-24	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Inférieur 2,50%	0,87	0,86	0,87	0,88	0,88	0,87	0,88	0,88	0,86	0,84	0,82
	Moyen 50%	1,24	1,24	1,24	1,24	1,23	1,22	1,22	1,21	1,18	1,15	1,11
	Supérieur 97,50%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

18	Prévalence du VIH: femmes 15-24	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Inférieur 2,50%	1,94	1,91	1,87	1,84	1,8	1,77	1,74	1,68	1,62	1,56	1,48
	Moyen 50%	2,19	2,16	2,14	2,11	2,09	2,06	2,04	2	1,94	1,87	1,79
	Supérieur 97,50%	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2

19	Nouvelles infections à VIH: hommes 15-24	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Inférieur 2,50%	3 693	3 694	3 655	3 517	3 539	3 496	3 503	3 205	2 951	2 723	2 493
	Moyen 50%	5 007	5 001	4 958	4 908	4 899	4 873	4 843	4 588	4 335	4 046	3 727

Supérieur 97,50%	6 170	6 310	6 221	6 166	6 295	6 424	6 393	6 172	6 057	5 731	5 411
------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

20

Nouvelles infections à VIH: femmes 15-24	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Inférieur 2,50%	7 741	7 694	7 560	7 314	7 320	7 156	7 101	6 492	6 128	5 630	5 124
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Moyen 50%	8 936	8 934	8 870	8 796	8 796	8 766	8 726	8 282	7 840	7 329	6 762
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Supérieur 97,50%	10 213	10 264	10 271	10 247	10 404	10 468	10 584	10 280	9 929	9 525	8 978
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

21

Décès annuels liés au sida: adultes 15-24	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Inférieur 2,50%	-1 138	759	704	797	891	913	774	671	582	497	430
-----------------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Moyen 50%	1 119	1 205	1 241	1 292	1 386	1 287	1 097	961	845	740	647
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----

Supérieur 97,50%	1 987	7 809	5 994	4 172	3 244	2 253	1 682	1 437	1 240	1 093	958
------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

22

Population VIH+ 10-19	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Inférieur 2,50%	28 847	29 829	31 098	32 019	32 807	33 726	34 472	34 914	35 224	35 145	34 522
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Moyen 50%	34 483	35 842	36 969	37 844	38 501	39 200	39 917	40 367	40 625	40 507	39 655
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Supérieur 97,50%	41 074	47 263	46 662	46 784	46 668	46 011	47 013	47 689	48 030	47 875	46 958
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

23	Nouveaux cas de VIH 10-19	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Inférieur 2,50%	2 669	2 667	2 606	2 565	2 592	2 610	2 575	2 434	2 310	2 140	1 945
	Moyen 50%	4 303	4 287	4 246	4 206	4 207	4 197	4 187	3 985	3 781	3 540	3 266
	Supérieur 97,50%	6 093	6 144	6 124	6 131	6 250	6 328	6 347	6 124	5 946	5 648	5 296

24	Décès annuels dus au SIDA 10-19	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Inférieur 2,50%	101	1 042	1 071	1 129	1 172	1 143	1 010	916	835	751	662
	Moyen 50%	1 125	1 221	1 265	1 321	1 380	1 291	1 154	1 062	980	899	806
	Supérieur 97,50%	1 473	4 043	3 361	2 686	2 297	1 461	1 330	1 241	1 164	1 093	1 007

25	Mères ayant besoin de PTME	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Inférieur 2,50%	30 201	30 201	30 183	30 462	30 542	30 770	32 126	33 729	34 964	35 559	36 421
	Moyen 50%	33 466	33 426	33 510	33 784	33 990	34 353	35 602	37 284	38 731	40 111	41 367
	Supérieur 97,50%	37 034	37 216	37 177	37 494	37 444	37 874	39 301	41 171	42 882	44 675	46 379

26	Orphelins du SIDA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Inférieur 2,50%	137 719	186 847	197 636	204 730	210 462	222 760	230 023	217 662	199 389	178 640	157 642
	Moyen 50%	299 449	301 556	303 703	308 099	311 940	319 126	316 178	302 350	282 766	259 544	234 239
	Supérieur 97,50%	906 152	768 566	738 032	706 330	689 131	671 221	567 967	476 908	418 359	374 731	335 300